

Asertywność w AvPD

Wyrażenie potrzeby = **ryzyko odrzucenia**. Linehan DEAR MAN — strukturalna sekwencja komunikatu. Bez treningu deklaracje, bez przekonań sztuczność. Działa tylko razem.

CZAS: 12 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Linehan (1993, 2015) DBT; Wolpe (1958); Lazarus (1971)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz wzorzec *submissive* w AvPD (sekcja 01). **2** · Poznasz **DEAR MAN** Linehan — siedem kroków komunikatu (sekcja 02). **3** · Zaplanujesz *pierwszy* trening asertywności w bezpiecznym kontekście (sekcja 03). **4** · Zrozumiesz, dlaczego DEAR MAN *plus* praca z przekonaniem „mam prawo do potrzeb” — działają tylko razem (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Asertywność w AvPD jest **ekstremalnie trudna**, bo wyrażenie potrzeby = *sygnalizowanie istnienia* = ryzyko odrzucenia. Osoby z AvPD są często *nadmiernie uległe* (ang. *submissive*) — rezygnują z własnych potrzeb, by uniknąć konfliktu. Skutek: frustracja narasta w izolacji, eksploduje (rzadko) lub generuje wycofanie z relacji. Druga strona nie wie o potrzebach — schemat „*odrzucają mnie*” potwierdza się przez brak zaspokojenia, którego nikt nie znał. Linehan (DBT, 1993) opisała protokół **DEAR MAN**: *Describe, Express, Assert, Reinforce, Mindful, Appear confident, Negotiate*. Struktura zdejmuje paraliż „*nie wiem jak to powiedzieć*”. Brak asertywności w AvPD ma **dwa źródła**: poznawcze („nie zasługuję”) i behawioralne (brak nawyku, brak struktury). DEAR MAN adresuje behawioralne, dziennik dowodów + ST adresują poznawcze. Razem — bez jednego sztuczność, bez drugiego deklaracje.

01 Wzorzec submissive — koszty milczenia

KRÓTKO: POZORNY SPOKÓJ

Pacjent milczy, zgadza się, rezygnuje z potrzeb. *Konflikt unikany*. Druga strona zadowolona. Pacjent — „użyło, nie musiałem walczyć”. Wstyd o potrzebę.

DŁUGO: RESENTMENT I WYCOFANIE

Frustracja narasta w izolacji. Resentment (urazenie, gniew tłumiony). Wycofanie z relacji: „*i tak mnie nie zrozumieją*”. Schemat *potwierdza się* przez brak zaspokojenia, którego nikt nie znał.

Paradoks AvPD: milczenie ma chronić relację — w istocie ją niszczy. Druga strona *nie wie* o potrzebach pacjenta. Z perspektywy partnera/szefa: „*wszystko było OK, czemu nagle się wycofał?*”. Wycofanie zaskakuje, schemat „*nikt mnie nie widzi*” potwierdza się — bo *nikt nie miał szans*.

02 🕒 DEAR MAN — siedem kroków Linehan

DESCRIBE — OPISZ SYTUACJĘ

Fakt, nie ocena. „W ostatnim tygodniu trzykrotnie odwołałeś nasze spotkanie” — nie „znowu odwołałeś, jak zawsze”.

EXPRESS — WYRAŻ UCZUCIE

„Czuję się pominięty/-a”. Komunikat „ja”, nie „ty zawsze...”. Konkretnie uczucie.

ASSERT — WYRAŻ POTRZEBĘ

„Potrzebuję, żebyśmy planowali spotkania z większym wyprzedzeniem”. **Konkret**, nie ogólnik.

REINFORCE — WSKAŻ KORZYŚĆ

„Dzięki temu obojgu nam łatwiej zaplanować tydzień”. Pokaż, że to win-win.

MINDFUL — NIE ZBACZAJ

Gdy próbuje zmienić temat / atakować — wracaj do swojej prośby. *Broken record*.

APPEAR CONFIDENT · NEGOTIATE

Postawa pewna (ton, postura) *nawet jeśli nie czujesz*. Negocjuj — zgódź się na rozwiązania pośrednie.

Klucz: DEAR MAN to *szkielet*, nie skrypt. Pierwsze użycia będą sztywne — to normalne. Po 5-10 użyciach struktura znika z głowy, zostaje umiejętność. Bez struktury — paraliż „*nie wiem od czego zacząć*” zwycięża.

03 ✎ Pierwszy trening — bezpieczny kontekst

ŁATWA SYTUACJA NA START

— np. zmiana zamówienia w kawiarni

BEZPIECZNA RELACJA DO TRENINGU

— terapeuta, przyjaciel, **NIE** krytyczny rodzic na start

KONKRETNE ZDANIE DEAR MAN

— ułóż przed rozmową

PROGNOZA VS WYNIK

— co przewiduję? co się wydarzyło?

04 💡 Struktura + przekonanie — działają tylko razem

SAM DEAR MAN BEZ PRZEKONAŃ

Sztuczność. Pacjent wypowiada słowa, ale *nie wierzy* w prawo do potrzeb. Brzmi mechanicznie. Pierwsza reakcja drugiej strony („to dziwne, dlaczego nagle...”) wystarcza do wycofania.

DEAR MAN + ST + DZIENNIK DOWODÓW

Struktura zdejmuje paraliż *jak*. Praca poznawcza buduje fundament *dlaczego mam prawo*. Razem: autentyczna asertywność. Bez jednego z elementów — fasada lub deklaracje.

Klucz: asertywność to *nie agresja* — to **szanowanie siebie i drugiego jednocześnie**. W AvPD próba zaczęcia od trudnej relacji (krytyczny rodzic, wymagający szef) kończy się porażką i potwierdza schemat. **Hierarchia jak w ekspozycji:** zacznij od najłatwiejszych sytuacji (drobna zmiana zamówienia w kawiarni, prośba o powtórzenie czegoś), buduj umiejętność stopniowo. Pacjent musi mieć *bezpieczny pierwszy kontekst* do treningu — najczęściej w terapii. Praca równolegle z przekonaniem „*mam prawo do potrzeb*” — bez tego DEAR MAN jest pustą formą.